

US-03 · Emitir receta médica digital.

Historia: Como médico del centro médico, quiero emitir recetas médicas digitales vinculadas automáticamente al historial clínico del paciente para eliminar el papel y garantizar que farmacia reciba la información en tiempo real.

Caso de uso relacionado: CU-03 (Emitir receta médica |RF asociado: RF-04)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Puede implementarse de forma aislada; depende de que el historial exista, no de otras US en desarrollo.
Negociable	Sí	Los campos de la receta (indicaciones, cantidad, medicamento) son negociables con el personal médico.
Valiosa	Sí	Digitaliza un proceso actualmente en papel, necesidad directamente expresada en EV-01.
Estimable	Sí	Estimable con base en el CU-03 especificado; complejidad media por la vinculación al historial.
Pequeña (Small)	Sí	Acotada a emitir y vincular la receta. La gestión de stock se cubre en RF-15.
Testeable	Sí	La vinculación inmediata al historial y la alerta de stock son verificables objetivamente.

Criterios de aceptación:

CA-01 — Escenario de éxito:

Dado que el médico tiene una atención activa con el paciente y completa todos los campos de la receta, cuando el médico confirma la emisión, entonces el sistema registra la receta vinculada al historial del paciente de forma inmediata y muestra "Receta emitida correctamente".

CA-02 — Escenario alternativo (stock insuficiente):

Dado que el médico selecciona un medicamento con stock por debajo del mínimo configurado, cuando el sistema verifica el inventario, entonces muestra la alerta "Stock insuficiente para este medicamento" y permite al médico seleccionar un medicamento alternativo o continuar con la indicación para adquisición externa.

CA-03 — Escenario de borde (cantidad inválida):

Dado que el médico ingresa una cantidad igual a cero o negativa, cuando intenta confirmar la receta, entonces el sistema resalta el campo en rojo, muestra "La cantidad debe ser mayor a cero" y bloquea el guardado hasta que el valor sea corregido.

CA-04 — Escenario de error (indicaciones vacías):

Dado que el médico deja el campo "Indicaciones" en blanco, cuando intenta confirmar, entonces el sistema resalta el campo como obligatorio y no procede al guardado.

▪ US-04 · Cancelar o modificar cita médica

Historia: Como paciente del centro médico, quiero poder cancelar o reprogramar una cita médica desde el sistema digital para liberar el turno a otros pacientes y evitar ausencias sin aviso que afecten la organización del centro.

Caso de uso relacionado: CU-04 (Cancelar cita médica | RF asociado: RF-06)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	Depende de que exista una cita agendada (US-01), pero puede desarrollarse como módulo separado.
Negociable	Sí	La política de cancelación (tiempo mínimo de anticipación, motivo obligatorio) es negociable.
Valiosa	Sí	Libera turnos automáticamente, optimizando la agenda sin intervención manual del personal.
Estimable	Sí	Estimable en puntos de historia; menor complejidad que el agendamiento (CU-04 ya especificado).
Pequeña (Small)	Sí	Acotada a cancelar o reprogramar. El agendamiento inicial es US-01.
Testeable	Sí	La liberación del turno en ≤ 2 segundos y el cambio de estado son verificables objetivamente.

Criterios de aceptación:

CA-01 Escenario de éxito:

Dado que el paciente tiene al menos una cita activa y selecciona "Cancelar cita", cuando confirma la cancelación, entonces el sistema cambia el estado de la cita a "Cancelada", libera el turno en ≤ 2 segundos y envía notificación de confirmación al paciente.

CA-02 — Escenario alternativo (paciente desiste):

Dado que el paciente inicia el proceso de cancelación pero no confirma,

cuando selecciona "No, mantener cita", entonces el sistema conserva la cita en su estado original y regresa al listado sin realizar cambios.

CA-03 — Escenario de borde (cita en curso):

Dado que el paciente intenta cancelar una cita que ya fue marcada como "En atención", cuando el sistema verifica el estado de la cita, entonces muestra "No es posible cancelar una cita en curso" y no realiza ningún cambio.

CA-04 — Escenario de error (sin citas activas):

Dado que el paciente accede al módulo sin tener ninguna cita activa registrada, cuando el sistema consulta su agenda, entonces muestra "No tienes citas activas para cancelar o modificar" sin ofrecer opciones de cancelación.

//MENSAJE COMMIT docs: user stories US-04 y US-05 con INVEST y criterios Gherkin TUJILLO 15/06/2026

▪ US-05 · Actualizar información clínica del paciente

Historia: Como médico del centro médico, quiero actualizar la información clínica de un paciente sin borrar el historial previo para mantener un registro completo y trazable de su evolución a lo largo del tiempo.

Caso de uso relacionado: CU-02 (Consultar historial clínico (flujo de actualización) RF asociado: RF-05)

Criterio INVEST	¿Cumple?	Justificación
Independiente	Sí	La actualización puede implementarse como extensión del módulo de historial sin afectar otras US.
Negociable	Sí	Los campos modificables y el nivel de trazabilidad del historial son negociables con el equipo médico.
Valiosa	Sí	Garantiza que el historial refleje siempre la evolución clínica real del paciente sin pérdida de datos.
Estimable	Sí	Estimable en puntos de historia; complejidad baja al reutilizar el formulario del módulo de historial.
Pequeña (Small)	Sí	Acotada a modificar campos existentes. El registro inicial se cubre en RF-01.
Testeable	Sí	El registro de fecha, hora y usuario de modificación es verificable directamente en la BD.

Criterios de aceptación:

CA-01 — Escenario de éxito:

Dado que el médico ha buscado y seleccionado a un paciente con historial existente, cuando modifica uno o más campos clínicos y confirma, entonces el sistema guarda los cambios con una marca de fecha, hora y usuario responsable, y el historial previo permanece visible como versión anterior.

CA-02 — Escenario alternativo (sin cambios realizados):

Dado que el médico abre el formulario de actualización pero no modifica ningún campo, cuando intenta guardar, entonces el sistema detecta que no hay cambios y muestra "No se realizaron modificaciones" sin generar un registro de auditoría innecesario.

CA-03 — Escenario de borde (campo obligatorio eliminado):

Dado que el médico borra el contenido de un campo obligatorio (como "Diagnóstico"), cuando intenta confirmar, entonces el sistema resalta el campo en rojo y bloquea el guardado hasta que sea completado.

CA-04 — Escenario de error (sesión expirada durante edición):

Dado que la sesión del médico expira mientras edita el formulario, cuando intenta guardar los cambios, entonces el sistema muestra "Sesión expirada, inicie sesión nuevamente" y conserva los datos ingresados en un borrador temporal para no perder el trabajo.